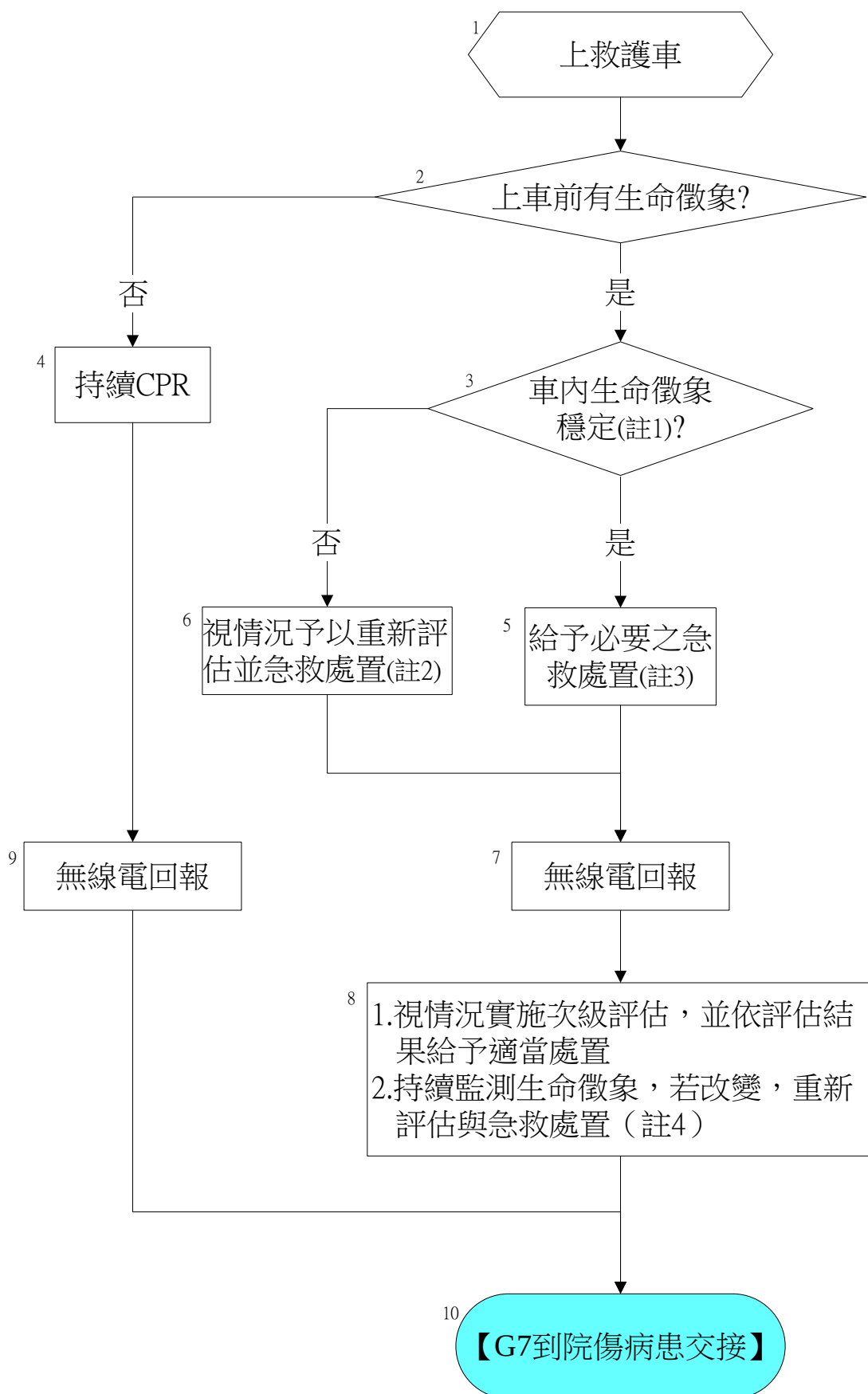


G6 車內照護

程 序



要 旨

- 一、「車內照護」是指將傷病患送上救護車後，至送達醫院前期間之處置。
- 二、駕駛：當傷病患上救護車，若有使用氧氣，駕駛可協助量測生命徵象及給氧設備之導管接至車裝氧氣上，並確認後座之EMT無需其它協助後，再儘速駛離現場。
- 三、救護員：應接續現場作為，完成必要處置及次級評估，並隨時注意個案變化，尤其是危急個案(ALS)可能出現之瀕死徵象。

註 解

註1>

生命徵象評估項目，包括意識、瞳孔、呼吸、脈搏、血壓、膚色、體溫及血氧濃度。

註2>

評估後之處置：

- 一、包括呼吸道處置：抽吸、口咽、鼻咽輔助呼吸道或進階呼吸道。
- 二、氧氣治療：鼻導管氧氣、面罩氧氣、非再吸入型氧氣面罩及BVM人工呼吸。
- 三、車上OHCA時：
 - (一) 若上救護車後尚未行駛前傷病患已 OHCA，應使用 AED 分析是否需電擊，若需電擊，電擊後持續 CPR 直至醫院。
 - (二) **若於救護車行駛間**傷病患 OHCA，1 名 EMT 應立即執行高品質 CPR，其他 EMT 協助操作 AED(醫療艙人力充足 時得不停車)；如原已貼妥 AED 貼片者，得先進行 AED 分析；另若預估送醫時間較長時，得停車急救，視情況架設 M-CPR 再起駛。
 - (三) 送醫過程中，EMT 考量傷病患為原發性 VF 時，可於行駛中（或暫停路邊）使用手動電擊器直接電擊或執行 AED 建議之電擊。
 - (四) 若使用 PAD，返隊後逕洽該場所（或維護廠商）。

註3>

- 一、依評估結果給予必要處置，包括：
 - (一) 低血糖：給予糖粉或含糖液體。
 - (二) 懷疑缺血性胸痛：視情況給予病人服用 NTG 舌下含片。
 - (三) 具刺激性或揮發性毒藥物中毒：將車窗打開。
 - (四) 若懷疑呼吸道或飛沫感染個案：應予戴口罩、打開車窗等，採取適當隔離保護措

施。

(五) 中暑等熱症病人：車上冷氣開至最大，可使用冰敷包於傷病患動脈點（頸部、腋下及鼠蹊部）。

(六) 低體溫病人：應注意保暖措施。

二、靜脈注射時機為：

(一) 休克傷病患，且預計送達醫院時間在 30 分鐘以上者，應於現場實施靜脈注射，嘗試注射以 2 次（或 5 分鐘）為限。

(二) 休克傷病患，且預計送達醫院時間少於 30 分鐘者，得於救護車上實施靜脈注射，嘗試注射以 2 次為限。

(三) 送達醫院之時間指「從評估病患為休克狀況開始至到院之時間」。

四、通報（通話）一般應注意事項：

(一) 不得施行無必要之通訊。

(二) 用詞必須力求簡潔，字句分明，口齒清晰，不易分辨的語詞應儘量避免使用。

(三) 通訊方法應力求正確，發現所發訊息有錯時，應立即更正。

(四) 重要的通訊內容，必須以接收者可用筆記錄下來的通訊速度發出。

(五) 數字、場所及姓名發聲必須清晰。

五、執行救護勤務回報時機及內容：

(一) 出勤、到達：回報已出勤、到達。

(二) 送醫途中：向救災救護指揮中心或急救責任醫院回報，內容包含：

1、自我介紹、傷病患性別、年齡、主訴。

2、介紹簡單病史、主要問題。

3、已做之急救處置。

4、目前之生命徵象。

5、大約幾分鐘到達醫院（傷病患屬危急個案應請醫院先行準備）。

註4>

抵達醫院前，後座的EMTP應持續監測傷病患的生命徵象及處置。危急個案至少每5分鐘測量1次；而非危急個案至少每15分鐘測量1次。當病患病情有變化時須重新評估處置。

一、送醫姿勢：

(一) 意識清醒：以傷病患最舒服之姿勢。

(二) 意識不清醒 (GCS<15)：以不影響呼吸道暢通及預防吸入性肺炎情況下得選擇復甦姿勢、半坐臥或平躺。

二、呼吸困難、心臟病病人、中風病人：半坐臥姿勢送醫。

三、孕婦：20週以上建議左側臥。

四、休克病人可考慮下肢抬高。